

1) Система тегов.

Задачи:

- 1) сегментирование пациентов для аналитики
- 2) маркировка для быстрого визуального анализа при открытии карты.

Основные тезисы:

- Тэги должны быть разноцветными, компактными, в конкретной области, легко воспринимаемыми.
- Автоматические теги, ручные тэги.
Автоматические назначаются системой. Примеры:
Массаж (если у пациента распланирован любой массаж), Долг (у пациента есть долг за услуги), Именинник, Давно не был (последняя выполненная услуга старше полугода).

Ручные теги - по сути как predetermined комментарии. Выбираются из Справочника, создаются новые. Но комментарии у нас и так есть, их видно, они цветные. Нужны ли такие тэги? Примеры?

- Отдельная роль для создания и редактирования ручных тэгов. Создавать могут только определённые пользователи.
- Срок жизни присвоенного тэга. Автоматический тэг пропадает, когда перестают выполняться условия. Должны ли некоторые ручные тэги автоматически удаляться из карты пациента по прошествии определённого времени?
- Общие и персональные тэги. Есть ли необходимость, чтобы был класс тэгов, которые в карте пациента видит только поставивший их пользователь?
- Присвоение цвета автоматически при создании тега с определённым шагом по палитре. Регистр занятых цветов.

2) История взаимодействий (Касания).

Дополнить в карте пациента форму Взаимодействия следующими видами взаимодействий:

- Телефонный звонок/Заявка/Чат (есть сейчас)
- СМС (есть сейчас)
- Чат-бот
- Оплата
- Возврат оплаты
- Отзыв о работе центра
- Заказ услуг
- Создание сделки
- Выполнение услуги
- Отмена услуги
- Комментарий менеджера
- ...?

Реализовать быстрые фильтры для отображения только конкретных видов касаний.

3) Сделки - переработать.

Что изменить?

Убрать приоритет? Первичная/повторная - никто не смотрит.

Цена назначения - проставлять автоматически, если было назначение врача.

Статусы сделки?

Какой принцип заведения сделки?

Могут ли вестись параллельно две сделки разным менеджерами по одному пациенту?

Отказаться от сделок! Работа вокруг задач и пациента, а не документа Сделки.

Статусы должны быть не у сделки, а у пациента. Пациент проходит лечение. После лечения - контроль и профилактика. Лечение может быть одновременно по разным случаям, у каждого может быть свой менеджер.

Статусы могут быть одновременно из разных классификаций в виде тегов.

Комментарии не к сделке, а к пациенту, фиксируются в истории взаимодействий.

Форма со списком задач менеджера, сверху сегодняшние пациенты на приёмах с отметкой ведущего менеджера. Менеджеры разбирают этих пациентов себе - автоматически создаётся задача со временем окончания приёма.

Как определить, кто ведущий менеджер у пациента? По последнему касанию?
Если менеджер временный?

Отображать в ПЗ менеджера, который взял задачу, чтобы врач знал, к кому вывести пациента.

Сопровождающие менеджеры?

4) Система задач.

Изучить механизмы библиотеки стандартных подсистем, проанализировать в нашей версии, адаптировать применение под наши цели.